

看護師主導の家族コミュニケーション介入 — 14研究2885家族、コミュニケーションの質と在院日数は改善するが心理症状は減らせない(系統的レビュー・CCM2026)

出典 Li Z, Lu F, Abshire Saylor M, Wu J, Reynolds NR, Wang J, Hwang H, Wang H, Wenzel J. Characteristics and Effectiveness of Nurse-Led Family Communication Interventions in the ICU: A Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Med. 2026;54(2):301-311. DOI: 10.1097/CCM.00000000000006952

掲載誌 Critical Care Medicine(2026-02)

原著 doi.org/10.1097/CCM.00000000000006952 (本文PDFは別途)

原題 Characteristics and Effectiveness of Nurse-Led Family Communication Interventions in the ICU: A Systematic Review and Meta-Analysis



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらないこと**: 家族の不安・抑うつ・PTSDを「看護師が話す量を増やす」ことで減らせる、という期待はこのレビューでも否定された。不安 SMD -0.10 (95%CI $-0.47 \sim 0.28$)、抑うつ SMD -0.13 ($-0.48 \sim 0.22$)、PTSD SMD 0.01 ($-0.15 \sim 0.18$) で、いずれも無効。ICUの家族支援介入は満足度を上げてでもPICS-Fは減らせない — 16施設885家族を1年追跡し全アウトカムで有意差なし(FICUSクラスターRCT・ICM2026) と同じ結論に、14研究・2885家族の統合でも到達している。ICテンプレート改訂の目的を「家族のPTSD予防」に置くのは根拠が弱い
- **変わりうること**: コミュニケーションの質 (SMD 0.26 、95%CI $0.12 \sim 0.40$) と在院日数 (MD -3.87 日、95%CI $-5.45 \sim -2.30$) は改善方向。加えて家族面談の回数と時間は確実に増える。当院で測るなら「家族が受け取った情報の質」と「面談が何日目に何回開かれたか」をプロセス指標にするのが現実的で、心理尺度を主要評価に据えるべきではない
- **誰にやらせるか**: 本レビューの最大の実務的示唆は、看護師を3タイプに分けたところ。①ベッドサイド看護師＝毎日会えるが心理支援の訓練と時間がない、②院内専任看護師 (internal research nurse)＝チームに組み込まれており長期的な効果が出やすい、③外部から雇った看護師 (external research nurse)＝忠実度は最も高いが、Butler試験では代理決定者のPTSDが増えた。当院で新しい役割を作るなら②の型、すなわち「ICUの中の人」に権限を与える形にする
- **役割設計の3条件** (討論部から): ①業務フローへの埋め込み (例: 合同ラウンドに同席させる)、②明示的な権限付与 (例: 資源調整の権限)、③チーム教育の継続。この3つを欠くと「役割の曖昧さ」と「文化的抵抗」で失敗する。日本のICUでも同じ壁に当たった記録がある (看護師ファシリテーターはなぜ効かなかったか — 役割の曖昧さと縄張り (質的研究・ICM2024))
- **開始タイミング**: 組み入れ研究の多数が入室後24～72時間以内に家族評価を開始し、初回家族面談も24～72時間以内に置いている。当院の3ステージプロトコル (ICテンプレート改訂) の第1ステージを「入室72時間以内」に固定する根拠として使える
- **投入量の目安**: 家族1組あたりの接触回数の中央値は2.4～9.4回、総接触時間は48～267分、患者1人1日あたりの投入時間は10.9～48分。つまり「1日あたり看護師の15～45分」を家族対応に確保できるかが実装可能性の分水嶺になる。ここがHotel ICUの人員試算に直接効く



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known:** ICU患者家族の心理的負担は大きく、代理決定者になるとさらに増える。3か月でPTSDが30～42%、12か月で32～80%に生じるとの報告がある。患者・家族中心ケアではコミュニケーションが知覚されるケアの質の決定因子であり、ICU看護師は医師と家族の情報ギャップを橋渡しする位置にいる。Adams らは成人ICU看護師の認識・障壁・戦略を、Scheunemann らは16の家族-医療者コミュニケーション戦略を整理していた
- **Unknown:** 「看護師が主導する」家族コミュニケーション介入だけを取り出したとき、その介入は具体的に何をどれだけやるものなのか(実施者・投入量・個別化の程度)、そしてどのアウトカムを動かすのか。既存レビューは戦略の列挙にとどまり、看護師主導という切り口での特徴づけと有効性の統合がなかった
- **What's new:** 14研究(RCT 7・準実験 7) 2885家族・3363患者を統合。①介入の共通型は「対面・構造化・入室中の動的調整」であること、②看護師が担う役割は5つ(情報伝達・情動支援・家族アセスメント・面談調整・移行期支援)に整理でき、実施者の3タイプで担当が体系的に異なること、③効果はコミュニケーションの質と在院日数に限定され、心理症状・満足度・ICU滞在・死亡には及ばないこと、を同時に示した。TIDieRで介入記述を、SWiMで非プール統合を、GRADEで確信度を並べた点も新しい



全体要約

要旨

ひとことで 看護師主導の家族コミュニケーション介入は、**コミュニケーションの質(SMD 0.26)と在院日数(-3.87日)**を改善する一方で、**家族の不安・抑うつ・PTSD・満足度、ICU滞在日数、死亡率のいずれも動かさなかった**。効果の有無を分けているのは介入の「型」ではなく、投入量と個別化の深さ、そして実施者がICUチームの内側にいるか外側にいるかである可能性が高い。

- 6データベース6972件から14研究(RCT 7、準実験 7)を採択。家族/代理決定者2885人(各研究26～809人、平均年齢47.2～58.9歳)、患者3363人(各研究26～1420人、平均年齢53.7～73.0歳)
- 実施国は米国9・フランス2・スイス1・中国1。デザインはRCT 5・パイロットRCT 1・クラスターRCT 1・準実験7
- 介入の最頻型は「対面・構造化・患者のICU在室中に動的に個別化する」もの。入室24時間以内の家族アセスメントで始まり、情報更新・多職種面談・退院後フォローへ続く
- 看護師の5つの役割:①情報伝達者・翻訳者、②情動支援者、③家族アセッサー、④面談コーディネーター、⑤移行期・フォローアップ支援
- 実施者3タイプで担当が分かれる。ベッドサイド看護師(5研究)は情報伝達と多面的家族アセスメントを全例で担当。院内専任看護師(6研究)は情報の明確化(6/6)・構造化された needs assessment(5/6)・面談調整を担当。外部雇用看護師(3研究)は家族面談支援(3/3)・構造化情動支援(2/3)・フォローアップ(2/3)に特化し、情報支援には関与しない
- 有効だったアウトカム:コミュニケーションの質 SMD 0.26(0.12～0.40、 $I^2=0\%$)、在院日数 MD -3.87日(-5.45～-2.30、 $I^2=0\%$)。加えて家族面談の回数と時間の増加、費用の低下(3研究中2研究で有意)
- 無効だったアウトカム:不安・抑うつ合計 MD 0.32(-0.96～1.60)、不安 SMD -0.10、抑うつ SMD -0.13、PTSD SMD 0.01、情報ニーズ満足 SMD 0.19(-0.36～0.73)、ICU滞在 MD -0.61日(-2.12～0.90)、6か月死亡 RR 1.03(0.81～1.32)、院内死亡 RR 1.11(0.81～1.52)
- GRADE確信度は「中」2項目(不安・抑うつ合計、6か月死亡)、残り8項目は「低」。異質性は多くの項目で I^2 47.8～75.6%
- 著者の結論:介入強度・実施者プロフィール(内部型 vs 外部型)・個別化の記述の異質性が大きく、結論は限定的。今後は最適な投入量の定義と、個別化・実装のベストプラクティスの明示が必要。医療機関はベッドサイド看護師への構造化コミュニケーション訓練、または専任コミュニケーション・ファシリテーター職の設置という形で看護の役割を制度に組み込むべき

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む ICUに入院した患者の家族は、患者が意思決定能力を失った時点で「代理決定者 (surrogate decision-maker)」という役割を背負う。これは単に説明を聞く立場ではなく、本人の代わりに生命維持治療の是非を決める立場であり、心理的負担が質的に変わる。その帰結として不安・抑うつ・PTSD・複雑性悲嘆が生じ、退院後も長く続くものを PICS-F (post-intensive care syndrome-family、集中治療後症候群・家族)と呼ぶ。ここに介入する発想は2つある。ひとつは医師が主導する家族面談の質を上げる方向、もうひとつが本論文の主題である「看護師主導」の方向である。看護師は患者の傍に最も長くいて家族と最も頻繁に接触するため、医師-家族間の情報ギャップを埋める位置にいる。この位置を制度化した役割にはいくつか名前があり、communication facilitator (コミュニケーション・ファシリテーター)、family navigator (家族ナビゲーター)、advanced practice nurse による family support intervention などがそれである。本論文はこれらを「看護師主導の家族コミュニケーション介入」として一括し、誰が・何を・どれだけ・どう個別化して行っているかを整理した。本文中の主な略語と道具立て: **PRISMA**=系統的レビューの報告ガイドライン。**PROSPERO**=レビューの事前登録データベース。**TIDieR** (Template for Intervention Description and Replication) = 複雑介入を「なぜ/何を(教材)/誰が/何を(手順)/どのように・どこで/いつ・どれだけ/個別化/忠実度」の枠で記述するチェックリスト。**SWiM** (Synthesis Without Meta-analysis) = メタ解析できない場合の統合報告ガイドライン。**Cochrane RoB 2** = RCTのバイアスリスク評価ツール。**JBIC Critical Appraisal Tools** = 準実験研究の質評価ツール。**GRADE** = アウトカムごとにエビデンスの確信度を高/中/低/非常に低で表す枠組み。**SMD** = 標準化平均差 (尺度が異なる研究を統合するときに使う)、**MD** = 平均差、**RR** = リスク比、**I²** = 研究間のばらつき (異質性) の指標。

2. 背景と目的

家族の心理的苦痛は入院中も退院後も続く。心配・悲嘆・持続する緊張に加え、睡眠障害や集中困難が生じる。患者が意思決定能力を失って家族が代理決定者になると、この負担はさらに大きくなる。愛する人のために重大な決定を下す責任は強い精神的ストレスをもたらし、不安・抑うつ・PTSD・長期化する悲嘆のリスクを上げる。数字としては、影響を受けた家族の30~42%が3か月以内にPTSDを発症し、12か月時点では32~80%に達するという報告がある。多くはPICS-F (心理・認知・身体症状の集合体)も経験し、これらは医療情報を処理する能力を損ない、意思決定への自信を下げる。

ICUの患者・家族中心ケアは、患者・家族の価値観とニーズにケアを合わせるための協働的コミュニケーションを重視する。効果的なコミュニケーションは知覚されるケアの質の決定因子である。医療者-家族コミュニケーションは情報交換・価値観の引き出し・共同意思決定を支えるが、実装上の障壁が複数ある。

障壁の層	内容
医療者側の制約	訓練・資源・時間の不足
システム上の課題	面談の日程調整、多職種での討議の調整
満たされないニーズ	情動支援、予後の話し合い、快適さ優先のケア (comfort care) についての会話

これらの不足が代理決定者の苦痛・意思決定上の対立・後悔につながっており、家族コミュニケーション戦略の改善が必要とされている。

ICU看護師は多職種間のコミュニケーション調整役として機能し、とくに重大な意思決定の局面で医師-家族間の情報ギャップを橋渡しする。共感的な存在 (empathetic presence)・時間の投入・情報共有を特徴とする看護師-家族の相互作用は、家族のICU体験を大きく形づくることが示されており、構造化された看護師主導の介入が家族の関与と知覚された支援を高めうると示唆される。しかし Adams らが成人ICU看護師の認識・障壁・戦略を概説し、Scheunemann らが16の家族-医療者コミュニケーション戦略を評価した後も、看護師主導の家族コミュニケーション介入の「特徴」と「有効性」についてはエビデンスギャップが残っていた。本レビューはこの限界に対応することを目的とする。

3. 方法(Methods)

- **報告ガイドライン**:PRISMA。プロトコルは PROSPERO に事前登録(CRD42024612634)
- **検索データベース**(6件):PubMed、CINAHL、Web of Science、PsychInfo、Embase、Cochrane Library。加えて組み入れ論文の引用文献リストを手作業で確認
- **検索期間**:1995年1月～2025年5月。最終検索は2025年7月1日に完了(抄録では「1995年1月～2025年7月」と記載されており、本文と表記が一致していない)
- **1995年を起点にした理由**:終末期治療とその意思決定に関するコミュニケーションを一変させたランダム研究(文献29)がこの年にあるため
- **検索語**:Medlineでのパイロット検索から、タイトル/抄録の関連キーワードと統制語を抽出。初期キーワードは "intensive care unit","communication","dialogue","family meeting","ethics consultation","hospice care","terminal care","palliative care","end-of-life care","decision-making","family","surrogate","nurse"。これを全データベース向けに適合させた
- **文献管理**:EndNote X9

Table 1. 組み入れ・除外基準(原表の日本語化)

項目	組み入れ	除外
デザイン	ランダム化比較試験、準実験研究	症例報告、総説、学会抄録、エディトリアル、専門家意見、QI(質改善)研究
セッティング	成人の集中治療・クリティカルケア	該当なし
介入	構造化された支援を通じてICU医療者-家族コミュニケーションを高める看護師主導の介入(主たる受け手は家族)。緩和ケアコンサルト、倫理コンサルト、意思決定/情報支援などの類似概念を含む	看護師主導の家族コミュニケーション介入を記述していない、または実施していない研究
アウトカム	家族中心アウトカム(不安、抑うつ、家族満足度、意思決定上の葛藤など)、または患者中心アウトカム(死亡、ICU滞在日数、ケア費用など)、またはプロセス関連アウトカム(家族面談の質など)で、看護師主導介入に紐づくもの	該当なし
対象	家族、および血縁・社会的関係(友人など)・法的関係(代理介護者などの法定代理人)でつながる者。家族の定義に関する法的・生物学的・社会学的・心理学的な文脈差や国・文化の違いは問わない	家族を参加者に含まない ICU患者のみの研究
言語	英語	該当なし

介入は「看護師が単独で、または他職種とともに主導する」ものでよいが、**看護師がコーディネートしていること**が必須条件とされた。

- **研究選択**: 3段階(①タイトル/抄録スクリーニング、②全文適格性評価、③量的統合のための全文レビュー)。2名の独立レビュアー(著者1・6)が「採用」「除外」「不確定」に分類し、不一致は第3レビュアー(著者2)を交えた討議で解決
- **データ抽出**: 標準化フォームへ抽出し独立にクロスチェック(著者1・4)。抽出項目は①出版情報(著者・年・セッティング・デザイン)、②介入詳細(TIDieR チェックリストに沿って記述)と患者/家族アウトカム
- **バイアスリスク評価**: RCTは改訂版 Cochrane RoB 2、準実験研究は JBI Critical Appraisal Tools。JBIは「yes」の割合でスコア化し、高品質($\geq 70\%$) / 中等度($\geq 65\%$) / 低品質($\leq 55\%$)と判定。不一致は第3レビュアーとの合意で解決。主要アウトカムには GRADE を適用
- **統計解析**: Stata v18。事前規定のランダム効果モデル。連続アウトカムは制限最大尤度法(REML)で解析し、平均差(MD)または尺度が異なる場合は標準化平均差(SMD)を95%CI付きで報告。二値アウトカムはリスク比(RR)でプール。異質性は I^2 で評価し、 **$I^2 \leq 50\%$ かつ $p > 0.1$ のときは固定効果モデルを適用**した

- **メタ解析不可のアウトカム**: SWiM ガイドラインに沿った記述的統合。研究を①看護師の役割(ベッドサイドICU看護師/院内専任研究看護師/外部研究看護師)と②アウトカム(苦痛/コミュニケーションの質/満足度/死亡/滞在日数)でグループ化。効果の方向(±/↑/↓)は2名の独立レビュアー(著者1・4)がコード化し、一致度は強かった($\kappa = 0.82$)。結果は記述的要約(補足表2・3)、SWiM表(補足表4・5)、GRADEエビデンスプロファイル表(Table 2)で提示

4. 検索結果とPRISMAフロー

図の解説

Figure 1. PRISMAフロー図。左端に4つの段階ラベル(Identification/Screening/Eligibility/Included)が青い縦帯で並び、中央の白い箱が上から下へ矢印でつながる。最上段は左に「データベース検索で同定した記録(n=6,969)」の箱があり、その中に内訳として MEDLINE n=1,187、PsycINFO n=188、Cochrane Library n=692、CINAHL n=683、Web of Science n=2,523、EMBASE n=1,696 が列挙される。右隣に「手作業検索で同定した記録(n=3)」の箱が並び、2本の矢印が合流して2段目の「重複除去後の記録(n=6,398)」へ入る。そこから右へ分岐する矢印が「タイトル・抄録に基づき除外した記録(n=6,206)」へ抜け、下向き矢印が「適格性を全文評価した論文(n=192)」へ続く。ここからも右へ分岐し「理由付きで除外した全文論文(n=178)」の箱に7項目が列挙される(学会抄録 n=6、対象が不適格 n=34、介入が不適格 n=67、研究プロトコル n=20、他の研究デザイン n=23、無関係のトピック n=26、関心のあるアウトカムがない n=2)。最下段は「レビューに組み入れた研究(n=14)」。

原図・無改変

同定6972件(データベース6969+ハンドサーチ3)のうち574件が重複として除去され、残る6398件のタイトル・抄録をスクリーニング。6206件を除外して192件の全文をレビューし、最終的に14件が組み入れ基準を満たした。

全文除外178件の理由(内訳)

除外理由	件数
介入が不適格	67
対象が不適格	34
無関係のトピック	26
他の研究デザイン	23
研究プロトコル	20
学会抄録	6
関心のあるアウトカムがない	2
合計	178

除外の最大要因が「介入が不適格」(67件)であることは、「看護師主導」「看護師がコーディネートしている」という条件が実質的に強い絞り込みとして働いたことを意味する。

5. 質評価の結果(Risk of bias)

RCT 7件(Cochrane RoB 2)

判定	件数	該当研究	主な懸念領域
低リスク	3	Butler 2025、Kentish-Barnes 2024、White (PARTNER) 2018	—
高リスク	2	Chiang 2017、Torke 2016	報告する結果の選択(selection of the reported result)
不明 (unclear)	2	Garrouste-Orgeas 2016、Curtis 2016	意図した介入からの逸脱、アウトカムデータの欠測、報告する結果の選択

準実験研究 7件(JBI Critical Appraisal Tools)

判定	件数	該当研究
高品質(≥70%)	3	Chen 2022、Naef 2021、Medland 1998
中等度(≥65%)	2	Shelton 2010、Daly 2010
低品質(≤55%)	2	White 2012、Ahrens 2003

詳細は補足表6(RCT)・補足表7(準実験)に収載。

6. 組み入れ研究の特徴

- 家族/代理決定者：合計2885人。研究別のサンプルサイズは26～809人、平均年齢47.2～58.9歳
- 患者：合計3363人。研究別のサンプルサイズは26～1420人、平均年齢53.7～73.0歳
- 実施国：米国9件、フランス2件、スイス1件、中国1件
- デザイン：RCT 5件、パイロットRCT 1件(Torke 2016)、クラスターRCT 1件(White 2018 PARTNER)、準実験研究7件

組み入れ14研究の一覧(本文・引用文献から再構成)

文献番号	第一著者・年	掲載誌	国	デザイン	実施者の型	介入の呼称・内容
37	Butler 2025	Am J Respir Crit Care Med	米国	RCT	外部研究看護師	Four Supports 介入(代理決定者向けの4領域支援)
38	Kentish-Barnes 2024	Intensive Care Med	フランス	RCT	院内専任研究看護師	看護師ファシリテーターによるコミュニケーション促進
39	Chen 2022	J Clin Nurs	米国	準実験(パイロット)	院内専任研究看護師	COMFORT コミュニケーション介入(代理決定者向け)
40	White 2018	N Engl J Med	米国	クラスター RCT	ベッドサイド ICU看護師	PARTNER(家族支援介入)
41	Chiang 2017	Intensive Crit Care Nurs	中国(香港)	RCT	ベッドサイド ICU看護師	双方向モバイル技術による心理・情報ニーズの充足
42	Garrouste-Orgeas 2016	Crit Care Med	フランス	RCT(原著は混合研究法と自称)	ベッドサイド ICU看護師	家族カンファレンスへの看護師の先行的(proactive)参加
43	Torke 2016	Am J Crit Care	米国	パイロット RCT	院内専任研究看護師	Family Navigator (家族ナビゲーター)
44	Curtis 2016	Am J Respir Crit Care Med	米国	RCT	外部研究看護師	コミュニケーション・ファシリテーター
45	Naef 2021	Aust Crit Care	スイス	準実験(混合研究法)	ベッドサイド ICU看護師	看護師主導の家族支援介入(専門看護師が実施)
46	Shelton 2010	Crit Care Med	米国	準実験	院内専任研究看護師	家族支援介入(満足度・在室日数・費用を評価)

文献番号	第一著者・年	掲載誌	国	デザイン	実施者の型	介入の呼称・内容
47	White 2012	Am J Crit Care	米国	準実験	院内専任研究看護師	進行した重症患者の代理意思決定を改善する看護師主導介入
48	Ahrens 2003	Am J Crit Care	米国	準実験	院内専任研究看護師	終末期の家族コミュニケーション改善(在室日数と資源使用)
49	Daly 2010	Chest	米国	準実験	外部研究看護師	長期滞在ICU患者家族への集中的コミュニケーション構造
50	Medland 1998	Am J Crit Care	米国	準実験	ベッドサイドICU看護師	構造化コミュニケーション・プログラム

7. 看護師主導の家族コミュニケーション支援のモデル(TIDieRに沿った記述)

7-1. Why(根拠・目的)

全研究に共通する根拠は、家族の心理的苦痛の緩和と、医療者-家族コミュニケーションの質の向上の2点だった。

7-2. What(教材)

8研究が介入での教材使用を報告した。

教材の種類	具体例	該当研究数
構造化コミュニケーション用紙	標準化プロトコル、家族の質問チェックリスト	6(37, 38, 40, 43, 47, 50)
専門訓練用教材	ロールプレイ・シナリオ、講義	4(38, 39, 42, 47)
家族支援用資材	情報パンフレット	2(42, 50)

7-3. Who(実施者)

家族コミュニケーション介入を主に担ったのは、ICUでの勤務経験があり、構造化コミュニケーション訓練を修了した看護師である。臨床上の役割と雇用関係により3タイプに分類された。

実施者の型	定義	該当研究(n)
ベッドサイドICU看護師	臨床ケアとコミュニケーションを兼務	5(40, 41, 42, 45, 50)
院内専任研究看護師(internal research nurse)	院内に置かれた専任のコミュニケーション支援者	6(38, 39, 43, 46, 47, 48)
外部研究看護師(external research nurse)	外部から雇用したコミュニケーション支援者	3(37, 44, 49)

7-4. What(手順)

看護師主導のICU家族コミュニケーション介入は、構造化されていること、全人的な範囲を覆うこと、動的に適応することの3つを示した。標準化された介入は入室後24時間以内の家族アセスメントで始まり、情報更新・個別化された調整・多職種面談・退院後フォローによる継続的支援へ続く。コミュニケーションのやり方は家族のニーズに合わせて変えられる。

看護師が果たす5つの役割：

役割	具体的な内容
①情報の伝達者・翻訳者	日々の医学的アップデート、医学情報の解釈・通訳
②情動支援者	情動面のアセスメント、悲嘆への支援
③家族アセッサー	ニーズ、懸念、認知、理解度の評価
④面談コーディネーター	面談の準備、同席、または主催
⑤移行期・フォローアップ支援	転棟・退院・死亡後の支援

実施者の型ごとに、担当する役割の分布が明確に異なった。

役割	院内専任研究看護師(6研究)	ベッドサイドICU看護師(5研究)	外部研究看護師(3研究)
情報の伝達	4/6(38, 39, 43, 48)	5/5(40, 41, 42, 45, 50)	0/3(関与なし)
情報の明確化	6/6(38, 39, 43, 46, 47, 48)	—	0/3(関与なし)
家族ニーズのアセスメント	5/6(38, 39, 43, 46, 48)	5/5(懸念・認知・ニーズ・理解度に焦点)(40, 41, 42, 45, 50)	—
家族面談の支援	4/6(38, 43, 46, 47)	3/5(40, 42, 45)	3/3(37, 44, 49)
構造化された情動支援	3/6(39, 43, 47)	—	2/3(37, 44)
意思決定の促進	3/6(46, 47, 48)	—	—
フォローアップ支援	—	—	2/3(44, 49)

外部研究看護師が情報支援にまったく関与していないことは、この型が「情報を持たない外部者」であることの構造的な帰結である。

7-5. How and Where(方法とセッティング)

対面(face-to-face)がICUでの情報提供の主要な手段であり(37, 38, 40～50 の計13研究)、これに以下が補完的に用いられた。

補完手段	該当研究
電話	38, 39, 43, 45, 50
書面資料	42, 50
ビデオ	38
双方向モバイル技術	41

セッティング：一般ICU(41)、外科系ICU(39, 45, 46, 49)、内科系ICU(39, 40, 43, 48, 49, 50)、内科外科混合ICU(40, 42)、脳神経ICU(39, 47, 49)、心臓・移植ICU(39, 45)。7研究が複数のICUにまたがって実施された(37, 38, 39, 40, 44, 45, 49)。

7-6. When and How Much(時期と量)

介入期間はICU入院期・移行期・退院後フォロー一期にわたる。

局面	内容	該当研究
開始時期	入室24～72時間以内に開始	37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 50
終了時期	転棟・退院・死亡まで	全研究がICU入院期の支援を含む
日々の接触	毎日の接触	37, 39, 40, 46, 47, 48, 50
初回家族面談	24～72時間以内	37, 40, 42, 44, 45
定期面談	5～7日ごと	37, 40, 47
追加面談	臨床的悪化・意思決定の必要が生じたとき	42, 44, 47
移行期の定義	転棟または終末期決定から転棟後/死亡後72時間まで。鍵となる時点で介入(転棟後72時間以内に1回、または決定時に1回)。 定義したのは3研究のみ	38, 45, 46
退院後フォロー	24時間～2年。3つのモデル: 段階的に頻度を減らす(38)／固定時点(43, 44, 45)／継続的支援(49, 50)	38, 43, 44, 45, 49, 50

投入量(intensity)の報告値は大きくばらついた。

指標	最小	最大
家族1組あたりの接触回数(中央値)	2.4回(Chen 2022)	9.4回(Curtis 2016)
総接触時間(平均)	48分(Chen 2022)	267分(Curtis 2016)
患者1人1日あたりの投入時間(平均)	10.9分(Naef 2021)	48分(White 2012)

7-7. Tailoring(個別化)

個別化の報告の程度は研究間で大きく異なった。

個別化の記述レベル	該当研究
概念に触れるだけ(例:「tailored support」と述べるが方法の記述なし)	1研究(37)
明確に操作化された記述あり	7研究(38, 41, 43, 44, 45, 46, 47)
高度に標準化されプロトコル駆動(=個別化なし)	6研究(39, 40, 42, 48, 49, 50)

個別化された要素として共通していたのは、①情報や支援内容の調整、②接触頻度・時間の変更、③アセスメントによって起動する事前定義モジュールの投入である。ただし約半数の研究は高度に標準化されたプロトコル駆動型の介入だった。

7-8. 実装と忠実度(fidelity)

7研究が忠実度評価を報告した。

評価方法	該当研究
音声・動画記録	37, 38, 39, 49
実施者チェックリスト	38, 42, 47, 50
第三者監査	37

忠実度の評価指標は、コア介入の完了率(43, 47, 49)、セッション時間(42, 47)、日々の接触率(43)、フォローアップ実行率(43, 47)から構成された。

プロトコル遵守率	件数	該当研究
高い(≥90%)	5	37, 39, 42, 43, 47
中等度(70～89%)	2	38, 49

忠実度を高める手立ては、主に構造化訓練(37, 43, 47)と多層的なレビュー機構(毎週の監査 37, 43／リアルタイム・フィードバック 39／四半期評価 47)に依拠していた。

8. 介入のアウトカム

Table 2. GRADEによるエビデンスの確信度(原表の日本語化)

看護師主導コミュニケーション介入 vs 通常ケア。

アウトカム	予想される絶対効果(95%CI)	参加者数(研究)	確信度(GRADE)	コメント
不安・抑うつ の合計	MD 0.32(−0.96～1.60)	1698(RCT 3件 [37, 38, 40]、準 実験 2件 [39, 45])	中(⊕⊕⊕○)	高い異質性 ($I^2=47.8\%$)
不安	SMD −0.10(−0.47～ 0.28)	1157(RCT 6件 [37, 38, 41～ 44]、準実験 1件 [45])	低(⊕⊕○○)	6件中2件が高バ イアスリスク、2件 が不明。高い異質 性($I^2=65.6\%$)
抑うつ	SMD −0.13(−0.48～ 0.22)	1157(RCT 6件 [37, 38, 41～ 44]、準実験 1件 [45])	低(⊕⊕○○)	6件中2件が高バ イアスリスク、2件 が不明。高い異質 性($I^2=60.9\%$)
PTSD	SMD 0.01(−0.15～0.18)	1669(RCT 5件 [37, 38, 40, 42, 44])	低(⊕⊕○○)	5件中2件が不明 リスク。高い異質 性($I^2=52.1\%$)
コミュニケ ーションの 質	SMD 0.26(0.12～0.40)	845(RCT 1件 [40]、準実験 1件 [39])	低(⊕⊕○○)	低い異質性 ($I^2=0\%$)
情報ニー ズの満足	SMD 0.19(−0.36～0.73)	104(RCT 1件 [41]、準実験 1件 [50])	低(⊕⊕○○)	RCT 1件が不明 リスク。低い異質 性($I^2=41.5\%$)
ICU滞在 日数	MD −0.61日(−2.12～ 0.90)	2692(RCT 3件 [37, 40, 44]、準 実験 3件 [46, 48, 49])	低(⊕⊕○○)	3件中1件が不明 リスク。高い異質 性($I^2=62.7\%$)
在院日数	MD −3.87日(−5.45～ −2.30)	1693(RCT 2件 [40, 44]、準実験 1件 [48])	低(⊕⊕○○)	2件中1件が不明 リスク。低い異質 性($I^2=0\%$)
6か月死亡	RR 1.03(0.81～1.32)	1711(RCT 2件 [37, 40])	中(⊕⊕⊕○)	高い異質性 ($I^2=75.6\%$)

アウトカム	予想される絶対効果(95%CI)	参加者数(研究)	確信度(GRADE)	コメント
院内死亡	RR 1.11 (0.81～1.52)	1864(RCT 3件 [37, 40, 44])	低(⊕⊕○○)	3件中1件が不明 リスク。高い異質 性(I ² =65.0%)

確信度の定義: ⊕⊕○○「低」=効果推定値への信頼は限定的で、真の効果は実質的に異なる可能性がある。
⊕⊕⊕○「中」=効果推定値におおむね自信があるが、真の効果はなお異なりうる。

8-1. 家族中心アウトカム

心理的苦痛(Psychologic distress)

不安・抑うつ合計(MD 0.32、95%CI -0.96～1.60、中等度確信度)、不安(SMD -0.10、95%CI -0.47～0.28)、抑うつ(SMD -0.13、95%CI -0.48～0.22)、PTSD(SMD 0.01、95%CI -0.15～0.18)のいずれにも有意な改善は認められなかった(後3者は低確信度)。異質性は中等度から高度(I² 47.8～65.6%)で、一部にバイアスリスクがあった。

実施者の型による下位グループ(記述的統合):

実施者の型	不安	抑うつ	備考
ベッドサイドICU 看護師	3研究中1研究で 低下(42)	一致しない(2研究で改善 [41, 42]、1研究で悪化 [45])	毎日の接触はあるが心理支 援の訓練が不足
外部研究看護師	—	2研究中1研究で6か月時点の抑う つに有益な可能性(44)	Butlerでは代理決定者の PTSDが増加(37)
院内専任研究看 護師	有意な効果なし (38, 43)	有意な効果なし(38, 43)	—

コミュニケーションの質

エビデンスは一致していないが、プール解析では有意な改善を示した(SMD 0.26、95%CI 0.12～0.40、低確信度、2研究 [39, 40])。下位グループでは、ベッドサイドICU看護師では有意な改善(1研究 [40])、院内専任研究看護師では有意な改善なし(1研究 [39])だった。

家族満足度

情報ニーズの満足に有意な改善はなかった(SMD 0.19、95%CI -0.36～0.73、低品質エビデンス、2研究 [41, 50]、参加者104人)。一方で記述的統合では、ベッドサイドICU看護師は家族の意思決定に対する満足

を高め(45)、院内専任研究看護師は医療チームへの満足を有意に改善した(46)。

8-2. 患者中心アウトカム

ICU滞在日数・在院日数

ICU滞在日数のプール解析では有意な短縮はなかった(MD -0.61日、95%CI -2.12～0.90、低品質エビデンス、 $I^2=62.7\%$ 、6研究 [37, 40, 44, 46, 48, 49])。下位グループでは、ベッドサイドICU看護師は1研究で有意な短縮を示し(40)、院内専任研究看護師は一致しなかった(1研究は効果なし [46]、別の1研究は正の効果 [48])。外部研究看護師は死亡した患者に限って有効だった($p < 0.01$ 、44)。

在院日数では有意な短縮が認められた(MD -3.87日、95%CI -5.45～-2.30、低品質エビデンス、3研究 [40, 44, 48])。ベッドサイドICU看護師(40)と院内専任研究看護師(48)はいずれも統計学的に有意な短縮を示し、外部研究看護師は死亡した患者でのみ有効だった(44)。

死亡

6か月死亡(RR 1.03、95%CI 0.81～1.32、中等度エビデンス、 $I^2=75.6\%$ 、2研究 [37, 40])、院内死亡(RR 1.11、95%CI 0.81～1.52、低エビデンス、 $I^2=65.0\%$ 、3研究 [37, 40, 44])のいずれにも差はなかった。ただし下位グループでは、ベッドサイドICU看護師は院内死亡を有意に増加させ、6か月死亡には影響しなかった(40)。院内専任(48)・外部(37, 44)研究看護師には有意な効果はなかった。

費用

3研究(44, 46, 48)のうち2研究で有意な費用低下が示された。Curtis 2016 ではICU総費用・ICU1日あたり費用・入院総費用が低下し、Ahrens 2003 では1症例あたりの病院変動直接費・間接費・固定費が低下した。

8-3. ICUプロセス関連アウトカム

看護師主導の家族介入は、医療者-家族面談の回数(37, 38, 49)と時間(49)を効果的に増加させた。

Table 3. 受容性と知覚された有効性(原表の日本語化)

出典	アウトカム	所見
Garrouste-Orgeas 2016(42)	知覚された有効性	①家族は、カンファレンスによって情報を受け取り消化できた、肯定的・否定的の両方の感情について耳を傾けてもらえた、共感と敬意を受けたと報告した。②看護師の参加に関する認識は4つのテーマに整理された:ICUスタッフが良く連携しているという信頼(50/88、56.8%)、アプローチが患者中心であるという信頼(33/88、37.5%)、情報が効果的に共有されているという信頼(15/88、17%)、家族の不安を和らげるためにあらゆる努力がなされたという信頼(12/88、13.6%)
Torke 2016 (43)	実施可能性	①介入群に割り付けられた代理決定者は、適格な患者在室日の90%以上で Family Navigator と接触した。全代理決定者が Family Navigator を他の家族に推奨すると同意または強く同意した。Family Navigator の接触が多すぎる、または時間を取りすぎたと同意した代理決定者はいなかった。②半構造化面接による医療者のフィードバックは非常に肯定的で、ある医師は「家族にとっては患者に何が起きているかをよりよく理解する助けになった。私たちにとってはケアの目標をずっと早く立てる助けになり、スタッフの苛立ちを減らした」と述べた
Naef 2021 (45)	知覚された有効性	①介入を受けた家族は、ケアされている、十分に情報を得ている、よりよく対処できると感じたと報告した。②面接参加者は、専門看護師(advanced practice nurse)が提供する支援介入が2つの意味で自らのウェルビーイングに有益だったと述べた:「認識されケアされること」と「個人として、また家族として支えられること」
White 2012 (47)	受容性と知覚された有効性	①すべての医師と代理決定者が、この介入を友人に推奨すると答えた。②医師と代理決定者の90%以上が、介入は次の3点をもたらしたと報告した:㉠コミュニケーションの質とタイミングの改善、㉡患者の価値観と治療の希望についての話し合いの促進、㉢ケアの患者中心性の向上

9. 考察

介入の3つの中核的特徴と、標準化と個別化の緊張

看護師主導のICU家族コミュニケーション介入は、構造化されたプロトコル、対面での提供、動的な適応性の3つを特徴とする。複雑介入理論(MRCの process evaluation ガイダンス)に照らすと、標準化されたプロトコルと文脈感受性のために必要な柔軟性のあいだに緊張がある。真の個別化の報告はばらつきが大きく、多くの研究は高度に標準化されたプロトコル駆動の介入を採用しており、適応の余地を封じて、個別化よりも運用上の再現性を優先していた。適応が文書化されていた場合でも、いわゆる動的適応性は表面的なままで、典型的には接触の頻度や時間を変える程度に限られていた。重要なのは、文化的背景や心理的特性といった核心

的側面への適応の証拠がほとんど見られなかったことで、個別化がより深く意味のある水準で実装されることはまれだったことを示す。社会的認知理論(Bandura)は人-環境-行動の相互作用を強調するが、個人差(例: コーピング特性)の無視が、苦痛の低減が限定的であったことの説明になりうる。

3タイプの看護師の能力と限界

実施者の型	強み	限界・リスク	構造的な含意
ベッドサイド ICU看護師	即時のコミュニケーションと日々の支援に優れる	高い業務量と心理学的訓練の不足により心理支援に限界	「接触頻度は高いが専門性は限定的」というプロファイル。ICU家族支援システム内で補完的役割を必要とする
外部研究看護師	高い介入忠実度を確保できる	意図しない効果を生じうる。Butlerの研究では代理決定者のPTSDが増加した。一過性・非統合的な役割であることが原因と推測される	忠実度と統合度のトレードオフ
院内専任研究看護師	深い臨床統合により、長期的な利益に構造的に有利な特徴を持つ	—	family navigator モデルが3つの相互強化メカニズムで例示:①ICUチームへの深い統合、②コミュニケーション調整と資源配分に関する正式な権限付与、③医師と協働した介入の直接実施

新しい看護役割をICUに組み込む際の2つの障壁

コミュニケーション・ファシリテーターなどの新しい看護役割を扱った研究(38, 43, 44, 46, 47, 49)は、ICUへの統合における2つの主要な障壁を同定した。

障壁	内容
文化的抵抗	役割の「新規性」が新しい相互作用パターンへの適応を強いる一方、チームはこの「新しい臨床家」を受け入れることに苦勞する(38)。抵抗はICUの階層的な硬直性と「深く根づいた役割期待」(47)、および役割と権力の緊張から生じうる。医療者は「自らの専門的役割を再概念化する」ことを求められ(46)、看護師は自分の機能が減ることを恐れ、医師は負担が減ったと述べた
役割の曖昧さ	誰が何をするかの境界が不明確になる

実装の成功には3つの要素が必要:①業務フローへの役割の埋め込み(例:合同ラウンド [47])、②明確な権限付与(例:資源調整の権限 [43])、③継続的なチーム教育(47)。

なぜ心理的苦痛が減らないのか

看護師主導のコミュニケーション介入が家族の心理的苦痛の低減において限定的かつ異質な有効性を示す理由として、著者は以下を挙げる。

仮説	内容
投入量(dosage)の不足・ばらつき	複雑な心理状態に影響するには、より高い支援水準が必要なことが多い
適応の浅さ	適応はおおむね表面的(例:接触のタイミング)で、より深い要因(例:コーピングスタイル)に踏み込むことはまれで、苦痛予防の効力を制限した可能性がある
ICU在室期間への偏った焦点	退院後のストレス(複雑性悲嘆、死別の準備)や、患者の予後という修飾不能な要因を見落としている

対照的に、コミュニケーションの質と在院日数の短縮ではより一貫した利益が見られた。これは、構造化されたプロトコルは投入量や個別化が低くても近位のアウトカム(proximal outcomes)を変えられることを示唆する。

10. 限界(著者の記載)

#	限界
1	英語論文のみを組み入れたため、関連するエビデンスを除外した可能性がある
2	有意な異質性と限られたデータのため、メタ解析はわずかなアウトカムでしか行えなかった。記述的統合とGRADEを用いたが、介入の「有効成分(active ingredients)」を完全に特定することはできなかった。とくに介入用量の報告が不均一であったため、正式な用量反応解析ができず、アウトカムのばらつきに寄与した可能性が高く、最適な支援強度の同定を妨げた
3	主要アウトカムのエビデンスの質は方法論上の欠陥のため大部分が低～中等度であり、強い臨床推奨を制限する

11. 批判的吟味(JCでの論点)

① 唯一の「有効」な家族アウトカムが2研究、実質1試験に依存している

コミュニケーションの質の SMD 0.26(0.12～0.40)は、RCT 1件(PARTNER、White 2018)と準実験1件(Chen 2022 のパイロット)の計845人から得られている。しかも著者自身の下位解析で、有意な改善はPARTNERのみで、Chen 2022 では有意でなかったと明記されている。つまりこのレビューの「ポジティブな結論」は、多職種による家族支援介入は家族の心理症状を改善しないがコミュニケーションの質を上げICU滞在を短縮する(PARTNER 段階的ウェッジRCT・NEJM2018) 1本のほぼ再掲である。参加者845人という数字が独立した根拠の厚みを示していると読むと誤る。

② 在院日数 -3.87日は「死による退院」の短縮かもしれない

在院日数のプールは3研究(PARTNER、Curtis 2016、Ahrens 2003)のみ。うち Curtis 2016 の効果は死亡した患者に限定されており、Ahrens 2003 は JBI で低品質と判定された準実験研究で、しかも2003年の研究である。死亡率が変わらないまま在院日数が短くなる場面には2つの解釈があり、①回復が早まった、②生命維持治療の中止がより早く決まった、のどちらかである。死亡を競合リスクとして扱った解析がないため区別できない。家族コミュニケーション介入の文脈では、②が主機序である可能性が十分にあり、その場合「在院日数の短縮」を効果指標として提示するのは価値中立ではない。この点についてレビュー本文に議論がないのは弱点である。

③ ベッドサイド看護師群で院内死亡が有意に増えたという記述が1行で流されている

結果の死亡の項に「ベッドサイドICU看護師は院内死亡を有意に増加させ、6か月死亡には影響しなかった(40)」とあるが、考察でこの安全性シグナルに触れていない。同様に、外部研究看護師(Butler 2025)で代理決定者のPTSDが増えたことは考察で言及されるものの、「一過性で非統合的な役割だから」という機序仮説を示すだけで、GRADE表や結論には反映されていない。**家族介入は無害だという前提で導入すると、この2つのシグナルを見落とす。**

④ GRADE判定が自らの理由記述と整合していない

Table 2 のコメント欄で、 $I^2=47.8\%$ を「高い異質性」と記載している。しかし方法では $I^2\leq 50\%$ かつ $p>0.1$ を固定効果モデルの適用基準としており、同じ47.8%を高異質性と呼ぶのは一貫しない。さらに6か月死亡は $I^2=75.6\%$ でありながら確信度「中」、院内死亡は $I^2=65.0\%$ で確信度「低」となっており、異質性の大小と確信度の順序が逆転している。確信度の格下げ理由が「バイアスリスクのある研究が含まれるか」だけで機械的に決まっており、異質性・不精確さ・非直接性が独立に評価されていない疑いがある。

⑤ RCTと準実験研究を同一のプール推定に混ぜている

不安・抑うつ合計はRCT 3件と準実験2件、ICU滞在日数はRCT 3件と準実験3件を一緒にプールしている。準実験研究は前後比較や同時対照のない設計であり、時間トレンドと施設効果を分離できない。RCTのみに限定した感度解析が報告されていないため、プール推定値がどちらに引かれているかが読者に判断できない。この設計上の選択は、参加者数を大きく見せる一方で推定の精度を過大評価する方向に働く。

⑥ 1995～2025年という30年の窓を横断してプールしている

Medland 1998、Ahrens 2003 の時代の「通常ケア」は、家族面談の標準化・面会方針・緩和ケアの統合いづれの面でも2024年の通常ケアと大きく異なる。対照群の質が時代とともに上がっていれば、古い研究は介入効果を過大に、新しい研究は過小に見せる。在院日数のプールに2003年の研究が含まれていることは、この時代効果を直接受ける。

⑦ 「最適な用量を定義せよ」と提言しながら、その用量を推定できていない

著者自身が限界として、用量報告の不均一さのため用量反応解析ができなかったと述べている。接触回数の中央値2.4～9.4回、総接触時間48～267分という4～5倍の開きは、介入が同一概念であるという前提そのものを揺るがす。このレビューが提供できるのは「必要な投入量はわからない」という情報であって、実装の意思決定に直接使える閾値ではない。

⑧ 家族満足度のプールは104人しかない

情報ニーズ満足の SMD 0.19 (−0.36～0.73) は、RCT 1件 (Chiang 2017、RoB高リスク) と準実験1件 (Medland 1998) の計104人から算出されている。この幅の95%CIは中等度の利益も中等度の害も排除できない。「満足度に効果なし」と読むのは過剰解釈で、正しくは「評価されていない」。

⑨ 実施者3タイプの分類は事後的 (post hoc) で、各セルに1～3研究しかない

このレビューの最も魅力的な知見である「内部型が有利、外部型は忠実度が高いが害もありうる」は、SWiMによる記述的統合であり、セルあたり研究数は1～3。効果の方向を2名がコード化して $\kappa=0.82$ という一致度は「分類の再現性」の指標であって、分類が真の効果修飾を捉えている保証にはならない。この分類は仮説生成として扱うのが妥当で、当院の役割設計の根拠にするなら「機序が説明可能か」(チームへの統合度、権限、情報アクセス)で判断すべきである。

⑩ 検索期間の記載が抄録と本文で食い違う

抄録は「1995年1月～2025年7月」、本文は「1995年1月～2025年5月、最終検索は2025年7月1日」。軽微だが、事前登録プロトコルとの照合が必要な種類の不整合である。

⑪ 出版バイアスの評価が報告されていない

アウトカムごとの研究数が最大7件であり、ファンネルプロットが解釈困難であることは事実だが、その旨の記載も含めて出版バイアスへの言及がない。看護介入研究の領域では小規模の陽性結果が出版されやすいことが知られており、コミュニケーションの質のような「柔らかい」アウトカムでは影響が大きい。

⑫ Garrouste-Orgeas 2016 の分類

原著タイトルは "a mixed-method study" であるが、本レビューはこれをRCTに分類し、RoB 2 で「不明リスク」と判定している。混合研究法の量的部分がランダム化されていたとしても、デザイン分類の根拠が本文に書かれていないため、7 RCT / 7 準実験という分割そのものが再現できない。

12. 主要な引用文献一覧

組み入れられた14研究

内容	著者・雑誌・年
代理決定者向け Four Supports 介入のRCT (外部看護師。PTSD増加のシグナル)	Butler RA, et al. Am J Respir Crit Care Med 2025;211:370-380
看護師ファシリテーターによるコミュニケーション 促進RCT(フランス多施設)	Kentish-Barnes N, Azoulay E, Reignier J, et al. Intensive Care Med 2024;50:712-724
ICUにおける COMFORT コミュニケーション — 代理決定者向け看護師主導介入のパイロット	Chen C, Sullivan SS, Lorenz RA, et al. J Clin Nurs 2022;31:3076-3088
PARTNER — ICUにおける家族支援介入のクラ スターRCT	White DB, Angus DC, Shields A-M, et al. N Engl J Med 2018;378:2365-2375
双方向モバイル技術による家族の心理・情報ニーズ 充足のRCT	Chiang VCL, Lee RLP, Ho MF, et al. Intensive Crit Care Nurs 2017;41:77-83
ICU家族カンファレンスへの看護師の先行的参加 の影響(混合研究法)	Garrouste-Orgeas M, Max A, Lerin T, et al. Crit Care Med 2016;44:1116-1128
Family Navigator — ICU家族代理決定者を支 えるパイロット介入	Torke AM, Wocial LD, Johns SA, et al. Am J Crit Care 2016;25:498-507
家族の苦痛と終末期ケアの強度を減らすコミュニケ ーション・ファシリテーターのRCT	Curtis JR, Treece PD, Nielsen EL, et al. Am J Respir Crit Care Med 2016;193:154-162
看護師主導の家族支援介入が満足度と心理的ウェ ルビーイングに与える影響	Naef R, von Felten S, Petry H, et al. Aust Crit Care 2021;34:594-603
家族支援介入の満足度・在室日数・費用への効果	Shelton W, Moore CD, Socaris S, et al. Crit Care Med 2010;38:1315-1320
進行した重症患者の代理意思決定を改善する看護 師主導介入	White DB, Cua SM, Walk R, et al. Am J Crit Care 2012;21:396-409
終末期の家族コミュニケーション改善 — ICU在室 日数と資源使用への含意	Ahrens T, Yancey V, Kollef M. Am J Crit Care 2003;12:317-323
長期滞在ICU患者家族への集中的コミュニケーシ ョン構造の有効性試験	Daly BJ, Douglas SL, O'Toole E, et al. Chest 2010;138:1340-1348
ICU患者家族への構造化コミュニケーション・プロ グラムの有効性	Medland JJ, Ferrans CE. Am J Crit Care 1998;7:24-29

背景・方法論・機序の主要文献

内容	著者・雑誌・年
PICS-F(集中治療後症候群・家族)の概念提示	Davidson JE, Jones C, Bienvenu OJ. Crit Care Med 2012;40:618-624
ICU患者家族の介護負担に関する文献レビュー(PTSD頻度の出典)	van Beusekom I, Bakhshi-Raiez F, de Keizer NF, et al. Crit Care 2016;20:16
患者・家族中心ケア介入のICUにおけるアウトカム(系統的レビュー・メタ解析)	Goldfarb MJ, Bibas L, Bartlett V, et al. Crit Care Med 2017;45:1751-1761
家族-医療者コミュニケーション戦略のレビュー(本レビューの先行研究)	Scheunemann LP, Ernecoff NC, Buddadhumaruk P, et al.
複雑介入のプロセス評価 — MRCガイダンス	Moore GF, Audrey S, Barker M, et al. BMJ 2015;350:h1258
社会的認知理論(個人差が効果を修飾する理論的根拠)	Bandura A. Annu Rev Psychol 2001;52:1-26
ICUでの死別後の複雑性悲嘆	Kentish-Barnes N, Chaize M, Seegers V, et al. Eur Respir J 2015;45:1341-1352
死別への準備 — 理論的枠組み	Hebert RS, Prigerson HG, Schulz R, et al. J Palliat Med 2006;9:1164-1171
ICU患者家族のPTSD症状リスク(FAMIREA)	Azoulay E, Pochard F, Kentish-Barnes N, et al. Am J Respir Crit Care Med 2005;171:987-994
家族の睡眠障害・不安・抑うつ・疲労	Çelik S, Genç G, Kinetli Y, et al. Int J Nurs Pract 2016;22:512-522
重症患者家族の半数が過度の日中眠気を経験	Verceles AC, Corwin DS, Afshar M, et al. Intensive Care Med 2014;40:1124-1131

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 看護師主導の家族コミュニケーション介入は、**家族の不安・抑うつ・PTSDを減らす手段としては期待できない**(不安 SMD -0.10、抑うつ SMD -0.13、PTSD SMD 0.01)。動くのはコミュニケーションの質(SMD 0.26)と在院日数(-3.87日)、そして面談の回数と時間である。**当院で家族支援の役割を作るなら、外部から人を雇うのではなく「ICUチームの内側にいる看護師」に権限と業務時間を与える形にする**。院内専任型は長期的な利益に構造的に有利で、外部雇用型は忠実度は高いが代理決定者のPTSDを増やしたRCTがある。**評価指標は家族の心理尺度ではなく、入室72時間以内の初回家族面談実施率と、家族が受け取った情報の質に置く**。1日あたり患者1人につき看護師の15～45分を確保できるかが、実装できるかどうかの分水嶺になる。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。